

# 大腸造口儲尿袋 (Indiana Pouch)

WARWIKI

病人須知 · 體內儲尿囊，用尿管排尿 — 唔使掛尿袋

大腸造口儲尿袋係用你自己嘅腸造成嘅體內儲尿囊，尿儲喺體內，透過腹部一個細小防漏開口（造口，通常隱藏喺肚臍）排出。你唔使掛尿袋，只需每日幾次用尿管插入造口排尿。Indiana Pouch 係最常見嘅款式。

## 關於呢個程序

醫生用一段大腸同小腸，喺腹腔內造成低壓儲尿囊；腎臟嘅輸尿管接入囊內。一條帶單向瓣嘅短通道引到皮膚表面 — 通常係肚臍 — 形成平坦細小嘅造口，兩次導尿之間保持乾爽。

- 你每**4-6 小時**插一次尿管排空儲尿囊。
- 你需要定期**沖洗儲尿囊**，清除黏液。
- **唔使掛尿袋** — 造口只需一塊細紗布或貼紙蓋住。

呢個方案適合唔想掛尿袋、唔適合或唔想做新膀胱，且能夠**長期可靠地自行導尿**嘅人 — 需要手穩、視力夠，或有照顧者協助。

## 安唔安全？

呢係成熟嘅手術方案。佢比導管造口術（urostomy）複雜，手術時間更長，且需要終身導尿。風險包括：出血、感染、吻合口滲漏；造口收窄或滲漏（可能需要修補手術）；囊內生石；黏液堆積；尿道感染 (UTI)；長期鹽分、維他命及腎功能變化（需定期覆診監察）。

### 詞彙解釋

#### 大腸造口儲尿袋

體內防漏儲尿系統 — 由你決定幾時排尿。

#### Indiana Pouch

最常見嘅儲尿囊，用右側大腸及小腸製成。

#### 儲尿囊

由腸造成嘅體內囊袋，用嚟儲存尿液。

#### 造口 (Stoma)

皮膚上嘅細小開口（通常喺肚臍），尿管由此插入。

#### 導尿

將細尿管插入造口，排空儲尿囊。

#### 沖洗

用清水沖洗儲尿囊，清除黏液。

#### 輸尿管

將尿液由腎臟帶到儲尿囊嘅管道。

#### 黏液

腸壁分泌嘅滑液；定期清除係日常護理嘅一部分。

**會唔會痛？** 手術係全身麻醉下進行，過程中完全唔會感覺到嘢。術後腹部會有酸痛感，腸道需要數日先「醒」返。你醒來時儲尿囊內已放咗引流管（加軟支架），需留置約 3-4 星期待癒合。期間需定期沖洗清除黏液。大多數人住院約 5-8 日。

## 點樣準備（手術之前）

- 手術需要**全身麻醉** — 跟足所有術前指示（禁食、按指示停服薄血藥）。可能需要**腸道準備**。
- 醫療團隊會規劃**造口位置**（通常係肚臍），並確認你或照顧者能夠**終身導尿**。
- **唔好吸煙**，並安排術後有人協助照顧。

如果你有以下情況，請提前告知醫療團隊：

- 正服用**薄血藥**，或現有感染
- 有**腸道疾病**、腎臟問題，或任何影響導尿嘅**手部或視力問題**

## 手術點樣做

- 1 你係麻醉下入睡，同時靜脈注射抗生素。
- 2 切取一段腸道，其餘腸道重新接通。
- 3 將腸道重塑成儲尿囊，帶單向瓣嘅導尿通道引到皮膚造口。
- 4 接駁輸尿管；放入引流管及軟支架，待癒合期間使用。

## 之後

- 約**5-8 日**後出院，帶住**引流管（約 3-4 星期）**；需定期沖洗清除黏液。
- 引流管取出、儲尿囊癒合後，每**4-6 小時**用尿管插造口排尿，並定期沖洗。
- 造口保持**乾爽** — 用細紗布或貼紙蓋住（唔使掛尿袋）。
- 有黏液係正常；多飲水；終身定期覆診（查維他命 B12、檢查儲尿囊）。約**6 星期內避免搬重物**。

**如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：**

- **插唔到尿管或排唔到尿** — 儲尿囊可能過滿，需緊急排尿
- 發燒或發冷
- 腹部劇痛、嘔吐，或**唔排氣、唔排便**
- 大量出血或血塊堵塞尿管，或傷口紅腫、有分泌物

## 要記住嘅三件事

1. Indiana Pouch 將尿儲喺體內，透過防漏造口用尿管排尿 — 唔使掛尿袋。
2. 你需要每 4-6 小時導尿一次，並定期沖洗清除黏液，終身如是 — 手穩視力好（或有助手）非常重要。
3. 術前禁食做好腸道準備，唔好吸煙，安排人協助。如果插唔到尿管或排唔到尿，立即求醫。